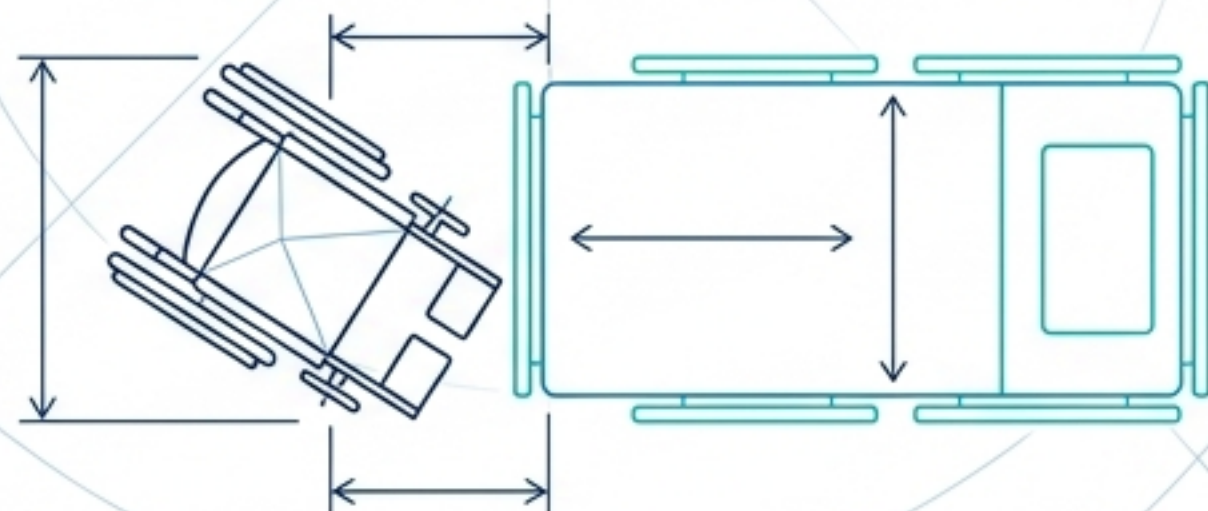


單元 07：病人輪椅、 病床間移位技術

照護安全藍圖與 18 項技術稽核標準

結合空間幾何、身體力學與同理心的標準化照護流程



五大核心照護階段

準備與評估

環境與輔具

床上坐起準備

移位執行核心

復原與安全觀察

題號 01-05

題號 06-08

題號 09-11

題號 12-14

題號 15-18

掌握五大階段，將死背的步驟轉化為流暢的肌肉記憶。

Phase 1: 準備與評估 (初始互動)

01

題號 01：能正確執行向病人說明病人輪椅、病床間移位目的。



核心目的

降低病人焦慮感，爭取過程中的主動配合，減少照護者施力負擔。

02

題號 02：能正確執行病人辨識。



核心目的

落實病人安全首要目標，確保處置對象無誤。

Phase 1: 準備與評估 (生理與環境確認)

感染控制



題號 03：能正確執行前、後洗手。

阻斷院內交叉感染途徑。

生理基線



題號 04：能正確向護理人員確認病人情況。

排除移位禁忌症（如嚴重姿勢性低血壓），確認當日體力狀態。

尊嚴與順暢



題號 05：能正確詢問病人是否要先如廁。

避免移位中途因尿急中斷，確保過程順暢與病人尊嚴。

Phase 2：環境與輔具設定 (絕對靜止錨點)

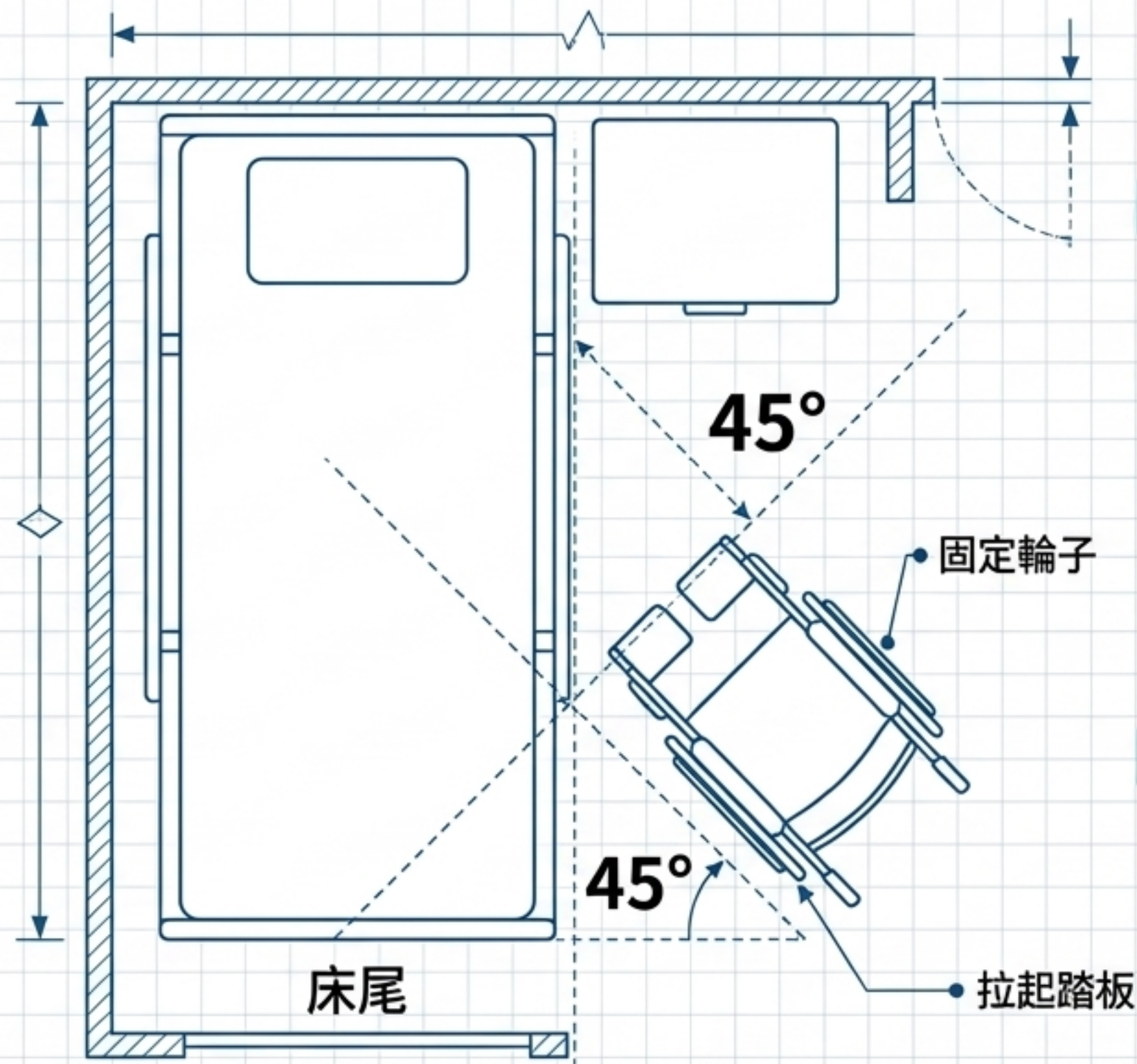


題號 06：能正確執行檢查床腳、輪椅是否安全（確實固定煞車）。

【零容忍的安全底線】 未確實固定煞車是造成移位跌倒的最常見主因。
床鋪與輪椅必須形成兩個絕對靜止的錨點 (Anchor Points)。

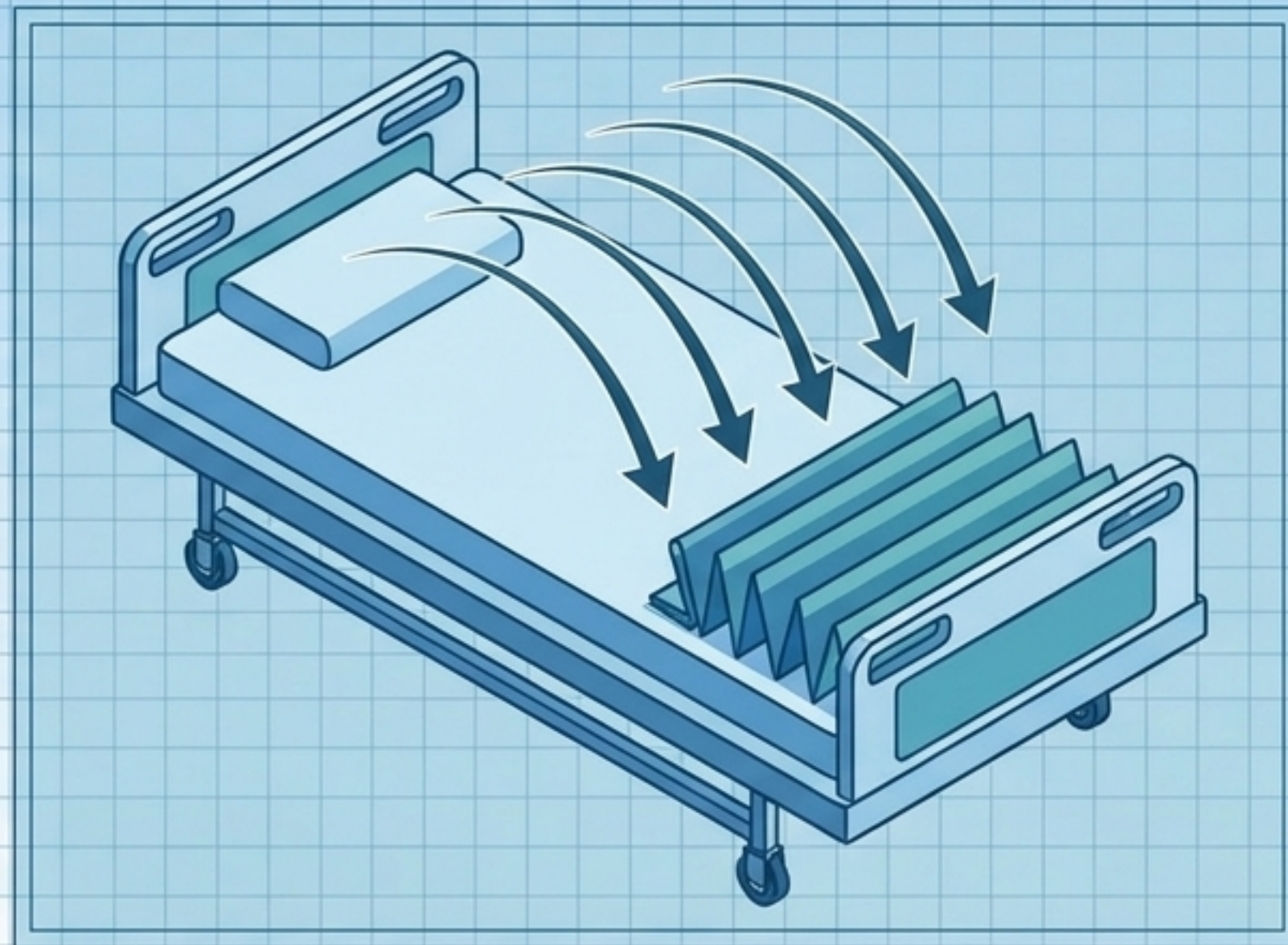
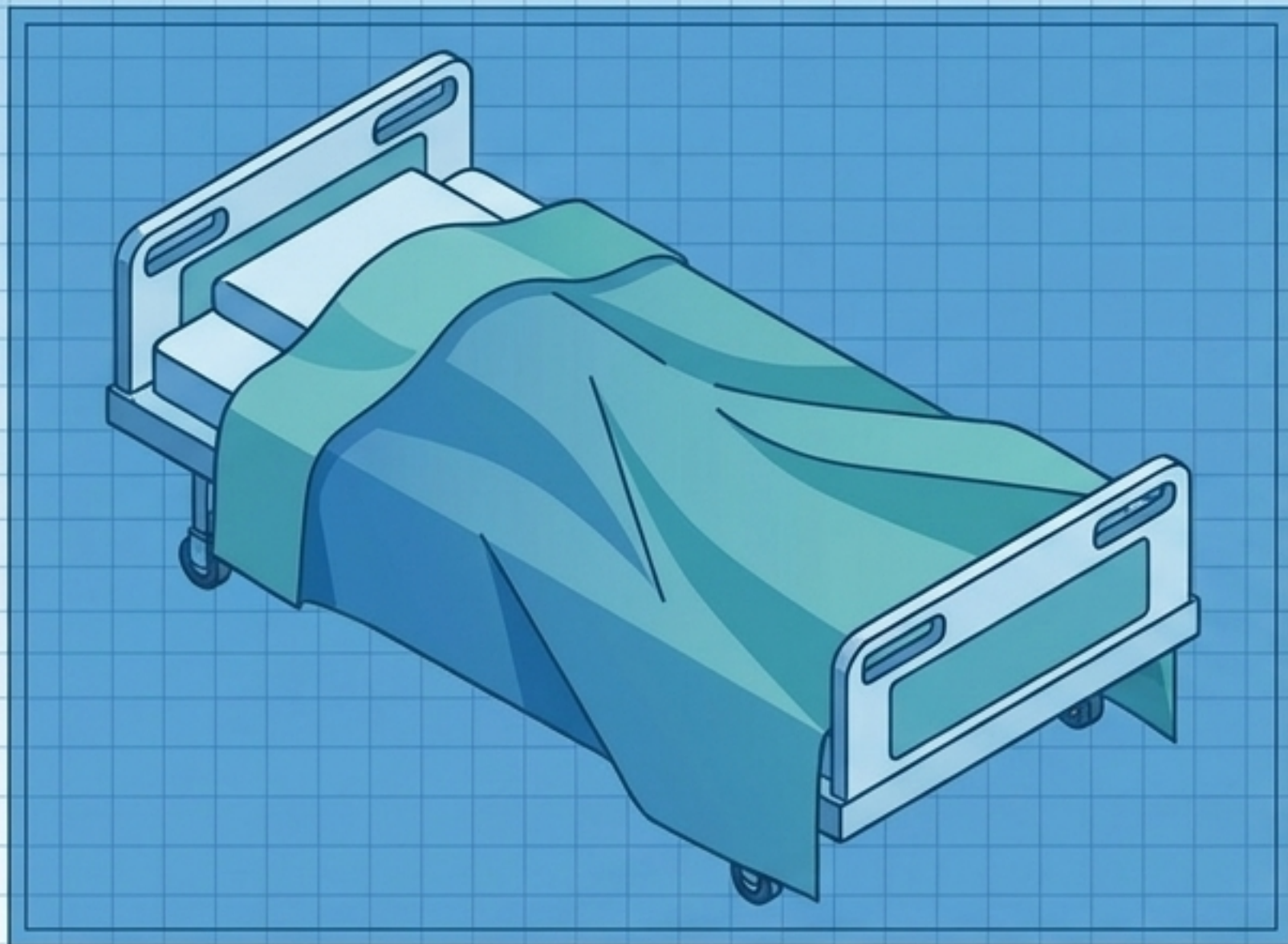
Phase 2 : 環境與輔具設定 (45度空間幾何)

題號 07：能正確將輪於床尾（椅背與床尾齊，正面向著床旁桌與床呈 45 度角，固定輪椅輪子或拉起踏板板）。



45度角能將照服員轉身的半徑降至最低，符合人體工學，同時讓病人看見目標位，減少空間迷失感。

Phase 2：環境與輔具設定 (扇形摺疊)



題號 08：能正確執行被蓋扇形疊至床尾。

扇形摺疊 (Fan-folding) 避免被子垂落成為絆倒危險，同時保持床面平整，利於病人後續的移動。

Phase 3 : 床上坐起準備 (機械輔助)

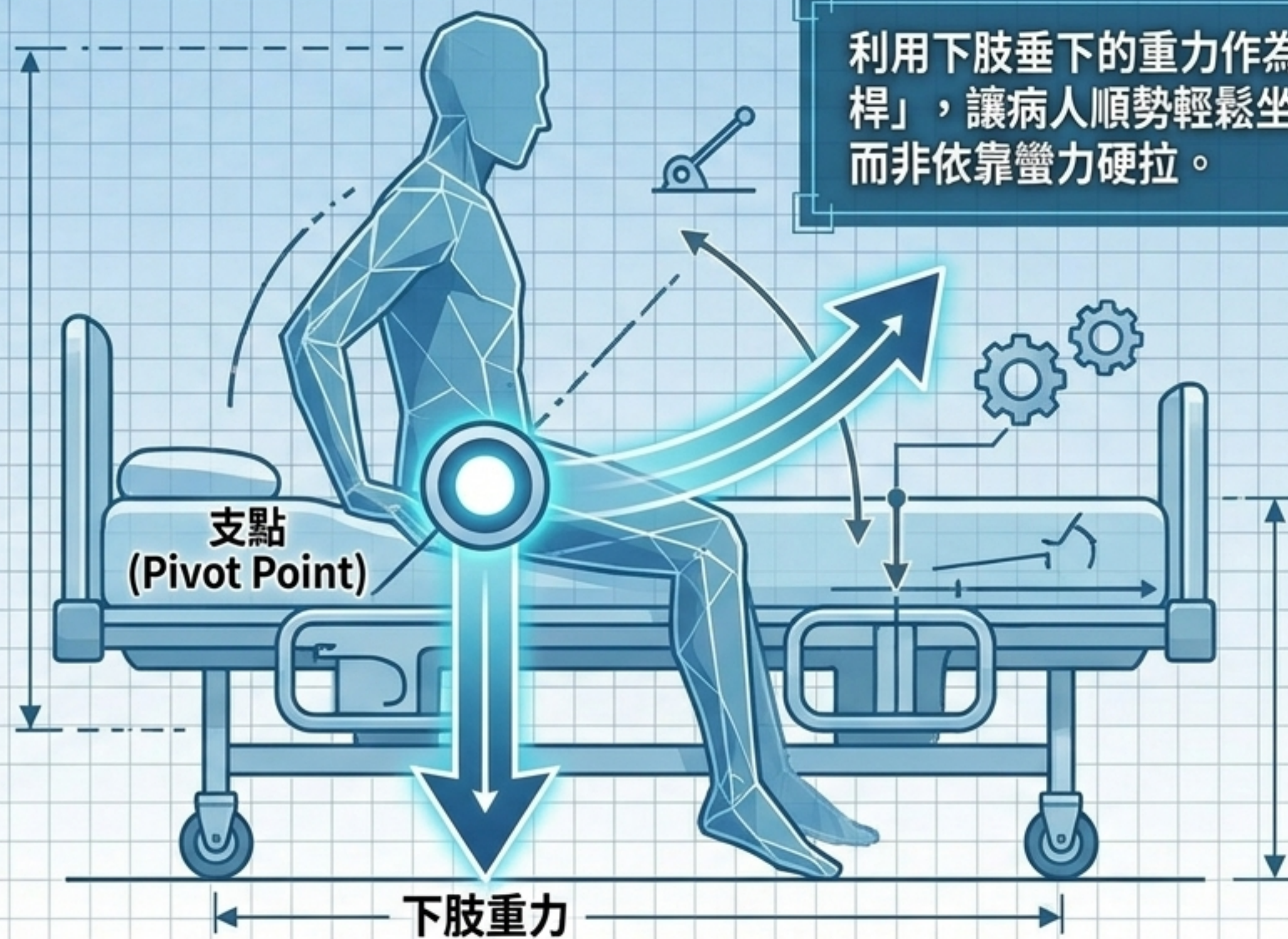
題號 09 : 能正確協助病人翻向欲坐起的床緣邊側臥，並拉起床欄，將床頭搖高。



利用電動床的機械力與重力，大幅降低照護者直接將病人拉起的腰背負擔（保護身體力學）。

Phase 3 : 床上坐起準備 (重力槓桿)

題號 10 : 能正確放下床欄，協助病人坐起，腳跨下床來。



Phase 3: 床上坐起準備 (黃金防線)



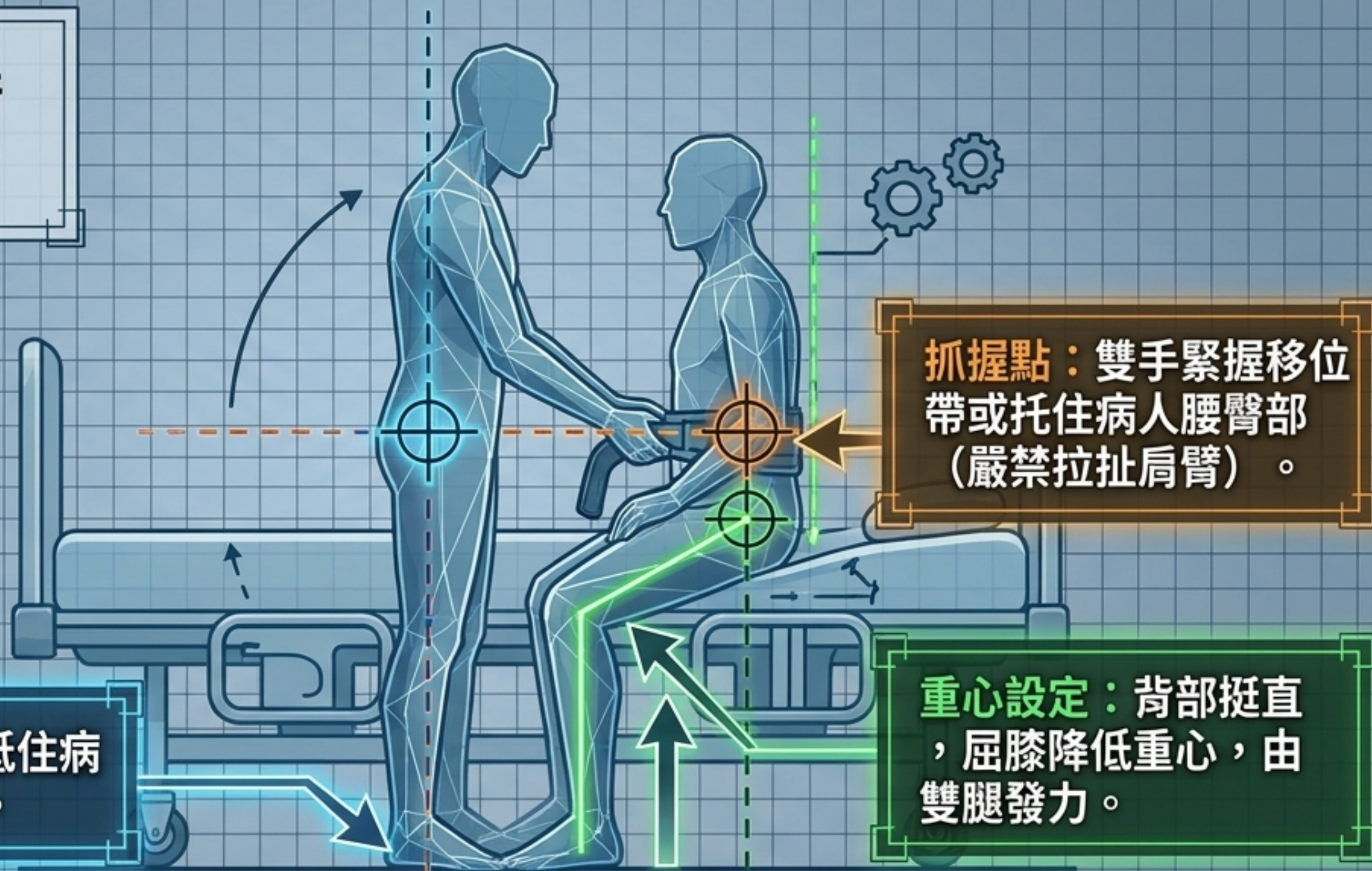
**題號 11：能正確協助病人坐於床緣
5-10 分鐘，並助其穿上外套、鞋子。**



【預防姿勢性低血壓 (Orthostatic Hypotension)】
從平躺到坐起，血液容易集中在下肢導致腦部瞬間缺血。給予 5-10 分鐘讓血壓穩定，是防止下床瞬間暈厥跌倒的黃金守則。

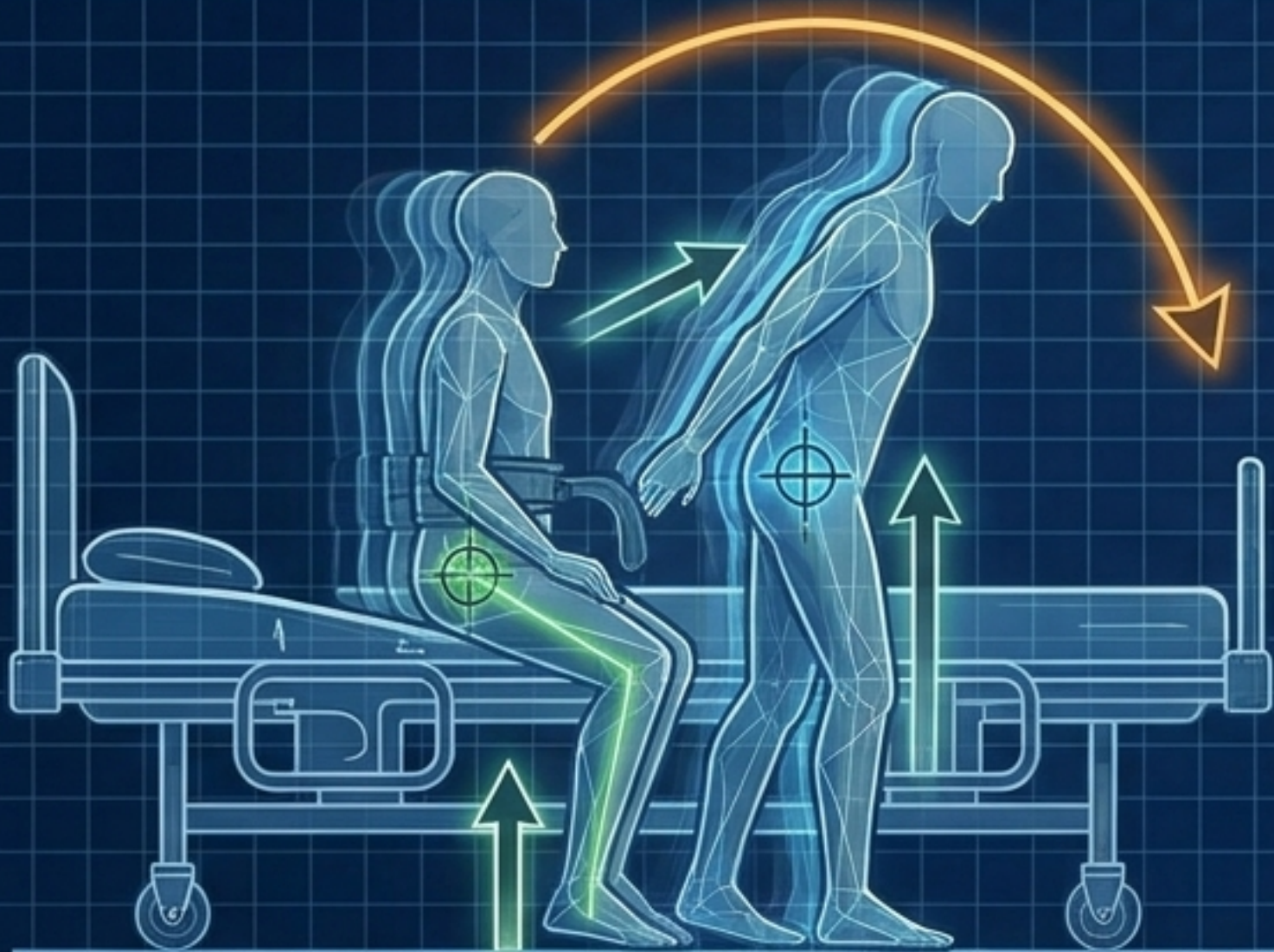
Phase 4: 移位執行核心 (起立準備與抓握設定)

題號 12：能正確執行
移位程序步驟一



Phase 4: 移位執行核心 (重心轉移與著座)

題號 13：能正確執行移位程序步驟二



引導病人向前傾，利用照護者雙腿力量共同站起。

題號 14：能正確執行移位程序步驟三



雙方以小碎步共同旋轉，直到病人小腿觸碰輪椅邊緣，引導其雙手向後扶握緩慢坐下。

Phase 5: 復原與安全觀察 (著座定位)



題號 15：能正確放下腳踏板，
將病人腳置於舒適的位置。



臀部坐至椅面最深處



雙腳平放穩固支撐



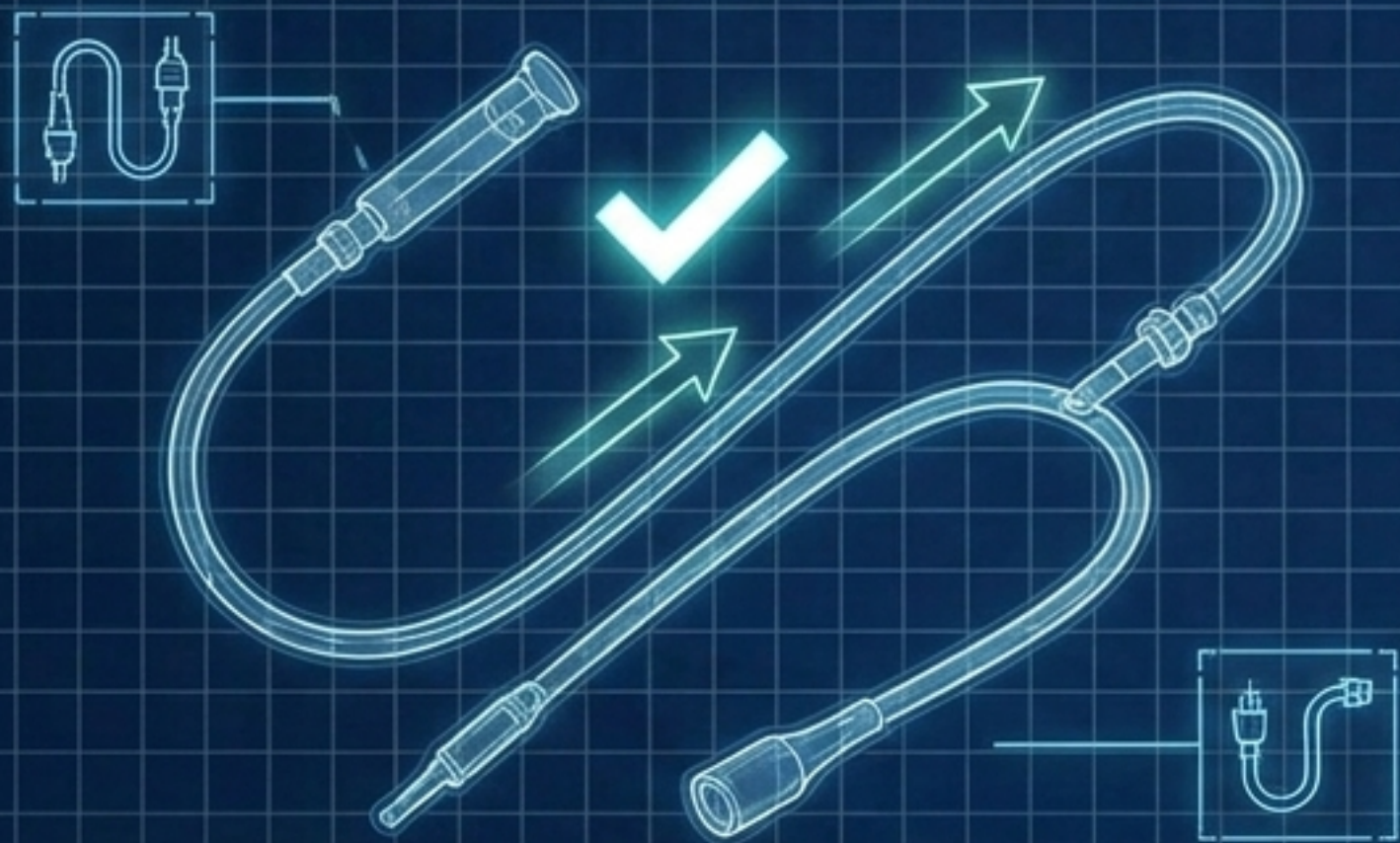
放下輪椅腳踏板

正確的足部支撐可維持骨
盆與脊椎的穩定坐姿，並避
免雙腳懸空拖行導致皮膚摩
擦受傷或捲入輪子。

Phase 5: 復原與安全觀察 (管路環境)

臨床管路安全

題號 16：能正確執行檢查管路是否暢順。



- 確保導尿管、點滴或氧氣管路未被拉扯、壓折或捲入輪椅輪軸。

環境復原歸位

題號 17：能正確執行用物處理及歸位。



- 病床降至最低，被服復原，確保叫人鈴 (Call Bell) 放置於病人可及範圍。

Phase 5: 復原與安全觀察 (最終生理評估)

題號 18：能正確執行觀察病人有無不適、疲乏、暈眩之徵狀。



不適 (Discomfort)
觀察表情痛苦或姿勢異常



疲乏 (Fatigue)
觀察異常喘息、呼吸急促
或面色蒼白



暈眩 (Dizziness)
攔截延遲性姿勢性低血壓，
觀察眼神渙散或肢體搖晃

移位是一項高耗能的身體活動，確實的最後評估能及早攔截潛在的併發症風險。
沒有完成這一步驟，移位程序就不算結束。

移位技術的核心維度

18項稽核標準的三維重構

溝通與觀察

- 01 說明目的
- 02 辨識
- 05 詢問如廁
- 11 等待 5-10 分鐘
- 18 觀察不適

照護的核心在於「人」，
隨時關注病人生理與心理狀態。

環境與輔具

- 03 洗手
- 06 煞車固定
- 07 45度角擺位
- 08 被蓋疊妥
- 16 管路暢通
- 17 用物歸位

零死角的前置作業，
是預防跌倒的絕對防線。

身體力學

- 09 側臥與床欄
- 10 槓桿坐起
- 12 移位一
- 13 移位二
- 14 移位三
- 15 腳踏板定位

善用重力與支點，保護病人的同時，
也保護照服員自己的腰背。

完美的稽核，來自對每一個細節「為何而做」的深刻理解。